POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

# Le carnet de douleur de vos patients

Une minute par jour pour le patient, deux minutes de lecture pour vous.

**OUCH v0.11.0**
Plaquette
5 novembre 2026

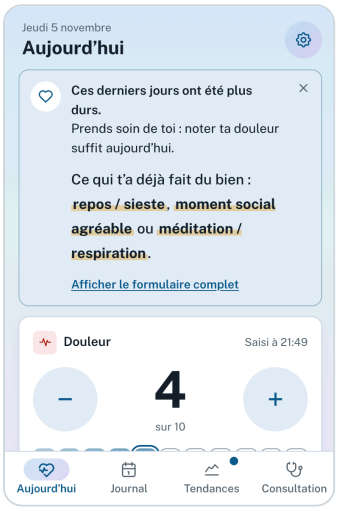
## OUCH EN BREF

Carnet de douleur libre et gratuit, pour la fibromyalgie et les autres douleurs chroniques. Le patient note sa journée en moins d'une minute sur son téléphone, sans compte ; ses données restent sur l'appareil. Il en tire un rapport pour la consultation, qui décrit les données sans les interpréter.

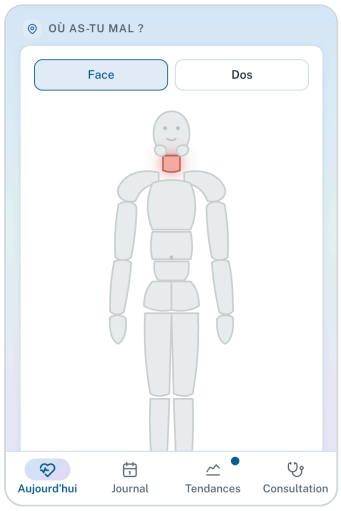
## CE QUE CELA CHANGE EN CONSULTATION

Des chiffres pris au jour le jour, plutôt qu'un récit de mémoire. Une comparaison à la période précédente, les jours nettement plus douloureux que d'habitude, les traitements pris avec le soulagement et les effets indésirables déclarés, et la question que le patient veut poser. Un appui pour l'anamnèse, pas une aide à la décision.

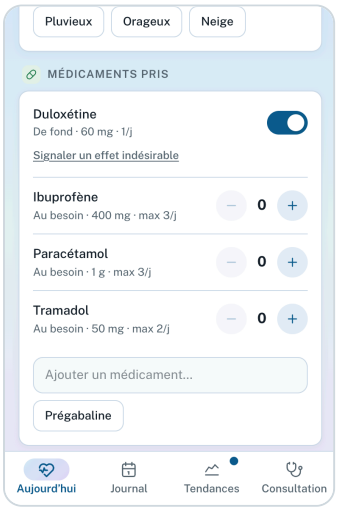
## CE QUE LE PATIENT SAISIT, EN MOINS D'UNE MINUTE




**Jours difficiles**
La douleur seule, en onze cases à toucher.




**Où, et comment**
Zones sur la silhouette, côté gauche ou droit.




**Traitements**
Prises, prises au besoin, effets indésirables.




**La courbe**
Moyenne sur 7 jours, jours plus difficiles ombrés.

## LE PATIENT NOTE

**Douleur du jour**, de 0 à 10 : la seule saisie dont une journée a besoin pour compter.
Échelle numérique recommandée pour l'intensité[1][3].
Notée au jour le jour : le rappel d'une seule journée est plus fidèle que celui de la semaine[6].

**Où ça fait mal**, sur 25 zones, gauche et droite.
Localisation et extension, jour par jour. Déclaratif, pas un critère de classification.

**Fatigue, sommeil, brouillard mental, humeur, stress, activité**, de 0 à 10.
Suivis à côté de la douleur. Échelles simples, non validées. Sommeil et douleur sont liés dans les deux sens[14].

**Selon les maladies** : raideur, réveils nocturnes, règles, mal de tête…
14 indicateurs facultatifs, non validés, relus rapidement en octobre 2026 par trois professionnels de santé.

**Traitements**, de fond ou au besoin.
Posologie réellement prise, jours oubliés, prises au besoin, soulagement, effets indésirables datés, changements de dose.

**Ce qui a aidé, météo, cycle, note.**
Facultatifs. Les approches non médicamenteuses que le patient repère lui-même ; le lien météo et douleur reste discordant[7][11–13].

### Les jours difficiles, une seule saisie

Seule la douleur suffit pour qu'une journée compte. Pendant une poussée, l'écran se réduit à la douleur ; le reste est proposé ensuite, sans insister.

Références numérotées comme dans la note méthodologique : [1] IMMPACT · [3] HAS · [6] Broderick · [7][11–13] météo · [14] Finan.

Captures d'écran de démonstration, données fictives. OUCH n'est ni un dispositif médical ni un avis médical ; les données sont auto-déclarées par le patient et non vérifiées.

OUCH · maxauvy.github.io/OUCH
Logiciel libre, licence CeCILL v2.1

## CE QUE VOUS RECEVEZ




Médecin traitant : phrase « En bref », chiffres clés, courbe




Centre douleur : le résumé de la page 1, avant les six parties numérotées

Le patient choisit une version (médecin traitant ou centre douleur). Le rapport couvre depuis son dernier rendez-vous du même type et le compare à la période d'avant.

- **Médecin traitant**, 3 à 5 pages : phrase « En bref », chiffres clés avec une flèche de tendance, courbe, répartition des jours comparée à la période d'avant, frise de ce qui s'est passé, traitements, ce que le patient veut aborder, points à retenir.
- **Ce que le patient a remarqué**, dans les deux : pistes gardées, essais d'une semaine, sans lien de cause.
- **Ce que le patient a ajouté**, dans les deux : ses questions et sa note après la consultation (qu'il peut écarter), ses périodes difficiles à part des poussées repérées, deux périodes comparées au choix.
- **Centre douleur (CETD)**, de 6 à 10 pages : un résumé, puis six parties numérotées (douleur, traitements, symptômes et sommeil, habitudes et contexte, questions et notes du patient, méthode), avec statistiques détaillées, jours plus difficiles (poussées) et leurs 3 jours précédents, sans lien de cause, chaque symptôme, antalgiques semaine par semaine, facteurs associés.
- **Dans les deux** : les maladies déclarées (diagnostiquée ou suspectée), la douleur par jour de la semaine avec sa bande de hasard, l'avant et l'après d'un changement de traitement, sans conclure ; la méthode.

Les jours non renseignés ne sont jamais comblés. Le PDF est fabriqué sur le téléphone ; le nom n'est pas enregistré, la date de naissance reste sur l'appareil.

## CE QUE FAIT OUCH

- ✓ Décrire : moyennes, médianes, répartition, évolution.
- ✓ Repérer les jours nettement au-dessus du niveau habituel du patient, appelés « poussées ».
- ✓ Citer la source de chaque seuil, et dire quand il est extrapolé.

## CE QU'OUCH NE FAIT PAS

- × Poser un diagnostic ou conseiller un traitement.
- × Remplacer un questionnaire validé ou votre examen.
- × Présenter une association comme une cause.

## CONFIANCE ET LIMITES

### Chez le patient

Données dans son navigateur : pas de compte, rien d'envoyé hors la météo facultative. Sauvegarde chiffrée (mot de passe de son choix), verrou par code facultatif.

### Libre et testé

Logiciel libre (CeCILL v2.1), code public. 536 tests automatiques vérifient les calculs et l'application.

### Franc sur ses limites

Données auto-déclarées. Échelles de fatigue, sommeil et humeur non validées. La définition des poussées est propre à OUCH, sans consensus.

## EN CONSULTATION, EN TROIS TEMPS

1. Le patient tient son carnet : une minute par jour, la douleur seule les jours difficiles.
2. Avant la consultation, il génère le rapport : version, dates, sujets à aborder.
3. Vous le lisez en deux minutes ; la note méthodologique détaille chaque calcul.

Captures d'écran de démonstration, données fictives. OUCH n'est ni un dispositif médical ni un avis médical ; les données sont auto-déclarées par le patient et non vérifiées.